TÓM TẮT LÝ THUYẾT · MẮT

BÀI 3 Viêm loét giác mạc

Tóm tắt từ bài giảng 3. Corneal Ulcer - Diagnosis & Treatment.pdf (19 trang) · Giữ ý chính và dấu hiệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU VÀ ĐẠI CƯƠNG
2. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤM
3. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI KHUẨN
4. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO HSV
5. CHẨN ĐOÁN
6. ĐIỀU TRỊ

1. GIẢI PHẪU VÀ ĐẠI CƯƠNG

- Giác mạc gồm **5 lớp** từ ngoài vào: **biểu mô → màng Bowman → nhu mô → màng Descemet → nội mô**; quan sát cắt lớp bằng **sinh hiển vi đèn khe**.
- Viêm loét giác mạc là **nguyên nhân đứng hàng thứ tư gây mù** trên thế giới.
- **Cơ chế bệnh sinh** (3 bước):
  - **Bám dính:** vi sinh vật bám trên **biểu mô bị khuyết**.
  - **Xâm lấn:** tăng số lượng và dàn trải (**2 ngày đầu**).
  - **Viêm và tổn thương mô: tiết men hủy mô**.

2. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤM

- **Yếu tố nguy cơ: kính tiếp xúc**, **chấn thương do thực vật**, **lạm dụng corticoid**, phẫu thuật (**LASIK, ghép giác mạc**), viêm bề mặt nhãn cầu mạn.
- **Triệu chứng:** đỏ, **đau nhức tăng về đêm**, nhìn mờ, chảy nước mắt, sợ sáng.
- **Dấu chứng:** cương tụ kết mạc; thâm nhiễm, phù, nhuyễn giác mạc với **bờ lông vũ**, **sang thương vệ tinh**, **bề mặt gồ**, sắc tố; **mủ tiền phòng**.

3. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI KHUẨN

- **Triệu chứng:** đỏ, đau, nhìn mờ, chảy nước mắt, sợ sáng.
- **Dấu chứng:** cương tụ kết mạc; thâm nhiễm **hình tròn / oval**, **bờ gọn, rõ**, **bề mặt nhẵy, phẳng hoặc lõm**; mủ tiền phòng.

Tác nhân	Đặc điểm
Staphylococci	**Gram (+) thường gặp nhất**; thuận lợi khi giác mạc bệnh lý (khô mắt, VGM Herpes, viêm bờ mi, dị ứng); **MRSA sau phẫu thuật laser**; staphylococci coagulase (–) có ở **85% mi mắt bình thường** → nhiễm trùng cơ hội
Streptococci	Sau **chấn thương, viêm túi lệ**, nhiễm trùng bọng; **diễn tiến nhanh, nhiều mủ, dễ thủng**
Pseudomonas	**Gram (–) thường gặp nhất**; liên quan **kính tiếp xúc**; **diễn tiến rất nhanh**, nhiều mủ, dễ thủng

4. VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO HSV

- **HSV-1:** hầu họng, mắt. **HSV-2:** niệu dục.
- Diễn tiến: **nguyên phát** (± triệu chứng) → **tiềm ẩn ở hạch thần kinh** → **tái hoạt** khi giảm miễn dịch.
- **Triệu chứng:** đỏ, nhìn mờ, chảy nước mắt, sợ sáng, **ít đau**.
- **Dấu chứng:** thâm nhiễm hình **cành cây, bản đồ**; **giảm cảm giác giác mạc**; có thể mủ tiền phòng.

5. CHẨN ĐOÁN

- Dựa vào **lâm sàng** và **soi tươi, nuôi cấy, nhuộm Gram, PCR**.
- **Bắt buộc làm xét nghiệm vi sinh** khi:
  - Thâm nhiễm **rộng, trung tâm, sâu**, có nhuyễn giác mạc.
  - Nhiễm trùng **kéo dài** hoặc **không đáp ứng kháng sinh phổ rộng**.
  - Có **tiền căn phẫu thuật giác mạc**.
  - Sang thương **không điển hình**, gợi ý **nấm, amíp, mycobacterium**.
  - Thâm nhiễm **đa ổ**.

6. ĐIỀU TRỊ

- **Thuốc:** tại chỗ / toàn thân **đặc hiệu theo tác nhân**.
- **Thủ thuật: dán keo**, tiêm thuốc nhu mô, **rửa tiền phòng**.
- **Phẫu thuật: ghép màng ối**, **ghép giác mạc điều trị**, **múc nội nhãn**.
- Viêm loét giác mạc là **cấp cứu nhãn khoa**: cần chuyển chuyên khoa sớm.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế bài giảng gốc. Đối chiếu 3. Corneal Ulcer - Diagnosis & Treatment.pdf khi cần chi tiết.